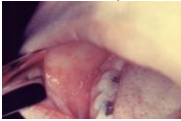
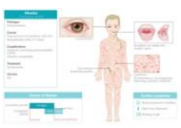
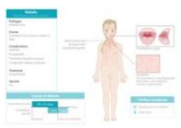
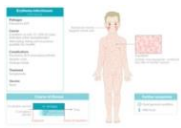
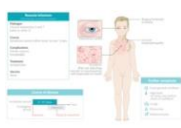
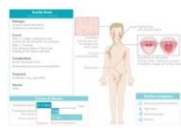
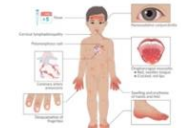
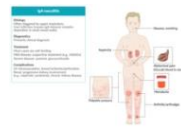


|                 | Rougeole                                                                                                                                                                                                                                                | Rubéole                                                                                                                                                                                                     | Érythème infectieux<br>(Mégaloérythème épidémique)                                                                                                                         | Roséole<br>(Exanthème subit)                                                                                                                                                               | Varicelle                                                                                                                                                                                                                               | Scarlatine                                                                                                                                                                               | Kawasaki                                                                                                                                                                                                 | Vasculite à IgA<br>(Purpura d'Henoch-Schönlein)                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agent pathogène | Paramyxovirus                                                                                                                                                                                                                                           | Togavirus                                                                                                                                                                                                   | Parvovirus B19                                                                                                                                                             | HHV6 et 7                                                                                                                                                                                  | VZV (HHV3)                                                                                                                                                                                                                              | Strepto. Groupe A                                                                                                                                                                        | Vasculite d'étiologie inconnue                                                                                                                                                                           | IVRS + Néphropathie IgA + Allergie médicamenteuse                                                                                                                                                                                       |
| Epidémiologie   | 3-7 ans                                                                                                                                                                                                                                                 | 2-15 ans                                                                                                                                                                                                    | 5-15 ans                                                                                                                                                                   | 6 mois-2 ans                                                                                                                                                                               | 5-15 ans                                                                                                                                                                                                                                | < 5 ans                                                                                                                                                                                  | < 10 ans                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Incubation      | 2 semaines                                                                                                                                                                                                                                              | 2-3 semaines                                                                                                                                                                                                | 4j-2 semaines                                                                                                                                                              | 5j-2 semaines                                                                                                                                                                              | 2 semaines                                                                                                                                                                                                                              | 2-4j                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Contagiosité    | -4/+4                                                                                                                                                                                                                                                   | -7/+7                                                                                                                                                                                                       | Jusqu'au rash                                                                                                                                                              | Inconnu                                                                                                                                                                                    | -2/+5                                                                                                                                                                                                                                   | + 3 semaines (1j si ATB)                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Durée exanthème | 7j                                                                                                                                                                                                                                                      | 3j                                                                                                                                                                                                          | 7-10j                                                                                                                                                                      | 1-3j <b>dès que l'EF baisse</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         | 7j                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Exanthème       | Maculo-papuleux érythémateux non prurigineux<br>Start derrière les <b>oreilles</b> puis visage, tronc, membres<br><b>Épargne paumes et plantes</b>                                                                                                      | Maculo-papuleux rosâtre non prurigineux<br>Start derrière les <b>oreilles</b> puis visage, tronc, membres<br><b>Épargne paumes et plantes</b>                                                               | Maculo-papuleux réticulaire un peu prurigineux<br>Start aux <b>joues</b> « slapped cheek », puis tronc, membres<br>S'accroît au <b>soleil</b><br><b>Épargne péri-orale</b> | Maculo-papuleux rosâtre non prurigineux<br>Start <b>tronc</b> et cou puis visage et membres                                                                                                | <b>Prurit sévère</b><br>Lésions de <b>différents stades</b><br>Vésicules superficielles claires sur base érythémateuse<br>Pustules ombiliquées avec croûte<br><b>Central</b> : visage, scalp, tronc<br><b>Épargne paumes et plantes</b> | Maculo-papuleux érythémateux en placard non prurigineux<br>Start cou puis tronc, plis et visage<br><b>Épargne péri-orale</b>                                                             | Maculo-papuleux érythémateux non prurigineux<br>Start tronc                                                                                                                                              | <b>Purpura palpable symétrique des parties déclives</b>                                                                                                                                                                                 |
| Symptomatologie | MEG<br><b>EF &gt; 40°C</b><br><b>Toux</b><br><b>Rhinite</b><br><b>Conjonctivite</b><br>ADP généralisées                                                                                                                                                 | BEG<br>Asymptomatique (50%)<br>EF < 38°C<br>ADP occipitales et rétro-auriculaires                                                                                                                           | BEG                                                                                                                                                                        | BEG<br><b>EF &gt; 40°C subitement</b><br>Fontanelle tendue<br>Possible pharyngite, toux, vomissements, diarrhée, œdème de la paupière<br>ADP occipitales, rétro-auriculaires et cervicales | EF<br>Céphalée<br>Arthralgie, Myalgie<br>Aphtes                                                                                                                                                                                         | <b>EF &gt; 40°C</b><br>Pharyngite, <b>Odynophagie</b><br>Douleurs abdo, N/V<br>ADP cervicale                                                                                             | <b>EF pour minimum 5 jours</b><br>Comme Scarlatine mais <b>conjonctivite bilatérale</b> en plus :<br><b>EF &gt; 40°C</b><br><b>Œdèmes et érythèmes des mains et pieds</b><br>ADP cervicale unilatérale   | BEG<br>EF < 38°C<br><b>Douleurs abdo, N/V</b><br><b>Arthralgies chevilles et genoux</b> : <b>Boitement</b>                                                                                                                              |
| Pathognomonique | Tache de <b>Koplik</b><br><br>(intérieur des joues)                                                                                                                    | Tâches de <b>Forchheimer</b><br><br>(palais mou)<br><b>Polyarthrite</b>                                                    | <b>Arthralgie symétrique</b> des petits articulations (doigts, mains, chevilles) et des genoux                                                                             | Tâches de <b>Nagayama</b><br><br>(palais mou et uvule)<br><b>Rash à la baisse de l'EF</b>                |                                                                                                                                                                                                                                         | Lignes de <b>Pastia</b><br><b>Langue framboisée</b><br><br><b>Desquamation 7-10j</b> post-fin du rash | <b>Langue framboisée, lèvres rouges et fissurées</b><br><br><b>Desquamation</b> du bout des doigts après 2-3 semaines | <b>Précédé d'une infection 1-3 semaines avant</b> :<br><b>IVRS Strepto. Groupe A</b><br><br><b>Purpura non thrombocytopénique palpable symétrique des parties déclives</b><br><br><b>Syndrome néphritique</b> : <b>Hématurie</b>        |
| Diagnostic      | <b>Sérologie IgM spécifiques</b> (rtPCR possible)<br>Leucopénie, Thrombopénie                                                                                                                                                                           | <b>Clinique</b><br>Si femme enceinte (Sy. congénital) : Sérologie IgM                                                                                                                                       | <b>Clinique</b><br>Si pas claire ou femme enceinte : Sérologie IgM<br><br>DD : PR : FR, anti-CCP                                                                           | <b>Clinique</b>                                                                                                                                                                            | <b>Clinique</b><br>Si pas claire : PCR ou sérologie                                                                                                                                                                                     | <b>Frottis culture</b><br>Test rapide antigène                                                                                                                                           | <b>Clinique</b><br>VS, CRP augmentées<br>Leucocytose, Thrombocytose<br>ASAT, ALAT augmentés<br>( <b>US coronaire</b> pour anévrisme)                                                                     | <b>Thrombocyte et coag normaux</b><br>VS, CRP augmentées<br>IgA sériques augmentées<br>Hématurie et protéinurie<br><b>Biopsie cutanée ou rénale</b> si pas claire :<br>Dépôt d'IgA et C3 complex<br>( <b>US abdo</b> pour invagination) |
| Traitement      | <b>Isolation 4j + Déclaration AINS + Vit. A</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>Isolation 7j + Déclaration AINS</b>                                                                                                                                                                      | Généralement <b>pas besoin</b> AINS<br>Prednison low-dose si arthrite                                                                                                      | <b>Paracétamol</b> pour EF                                                                                                                                                                 | <b>Paracétamol</b><br><b>Pas d'Aspirine !</b><br>Compresse froide et lotion de calamine ou pramoxine pour le prurit                                                                                                                     | <b>Pénicilline V p.os</b>                                                                                                                                                                | <b>IVIG haute dose</b> (diminue risque anévrisme coronaires)<br><b>Aspirine haute dose</b> ( <b>Ne répond pas aux ATB</b> )                                                                              | <b>Stop médic si allergie</b><br><b>Hydratation et AINS</b> (Corticostéroïdes p. os si sévère)                                                                                                                                          |
| Complication    | Surtout si l'EF persiste après qqes jours :<br>- Surinfection bactérienne (Otitis moyenne, Pneumonie)<br>- Encéphalite aigüe<br><br>Encéphalite sclérosante (> 7 ans post-infection)<br>- Démence<br>- Épilepsie<br>- Décérébration<br>- État végétatif | - Arthrite chronique (femme++)<br>- Purpura thrombocytopénique<br><br>Si femme enceinte :<br>Syndrome congénital (infection TORCH)<br>- Persistance du canal artériel<br>- Cataract<br>- Déficit cochléaire | - <b>Crise aplasique</b> : Anémie sévère et réticulopénie ttt : transfusion<br><br>Si femme enceinte : (infection TORCH)<br>- Hydrops<br>- MIU<br>- FC                     | - Convulsions fébriles<br>- Encéphalite (rare)                                                                                                                                             | - Surinfection bactérienne<br>- Zona<br>- Cicatrice<br>- Pneumonie<br>- Ataxie cérébelleuse aigüe                                                                                                                                       | - Abscès rétro-pharyngé ou péri-tonsillaire<br>- Glomérulonéphrite post-streptococcique                                                                                                  | - <b>Anévrisme des coronaires</b><br>- Infarctus du myocarde<br>- Arythmies                                                                                                                              | <b>Invagination intestinale</b><br><b>Syndrome néphrotique</b><br><b>IRC</b>                                                                                                                                                            |
| Prévention      | Vaccin ROR (9 et 12 mois)<br>PEP                                                                                                                                                                                                                        | Vaccin ROR (9 et 12 mois)                                                                                                                                                                                   | Bon pronostique                                                                                                                                                            | Bon pronostique                                                                                                                                                                            | Vaccin                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          | Bon pronostique                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |



## MALADIES ÉRUPTIVES DE L'ENFANT

Chez l'enfant, les maladies éruptives correspondent le plus souvent à des infections virales sans gravité. À l'occasion, elles peuvent représenter une menace pour des contacts réceptifs plus vulnérables: nouveau-nés, femmes enceintes et individus immunodéprimés.

L'aspect de l'éruption, les signes et les symptômes accompagnateurs, l'âge de l'enfant et le contexte épidémiologique permettent généralement d'identifier l'agent infectieux.



La scarlatine, et la roséole sont toujours fréquentes. L'usage généralisé du vaccin contre la varicelle va très certainement freiner l'activité d'un virus en milieu scolaire.

Les vaccins ont grandement réduit les cas de rougeole et de rubéole.



L'incidence des infections saisonnières, cinquième maladie et maladie "mains-pieds-bouche", varie d'une année à l'autre.



Les purpuras méningococcémiques sont rares mais tout particulièrement redoutables.



De nouvelles maladies ont été décrites: la maladie de Kawasaki, de rencontre occasionnelle et d'origine mystérieuse, et la maladie de Gianotti-Crosti, expression assez fréquente de diverses infections virales.

# CINQUIÈME MALADIE (érythème infectieux)

Parvovirus B19

Incubation:  $\pm$  14 jours



Éviction scolaire non indiquée  
(maladie non contagieuse au stade éruptif)



Fin de l'hiver et printemps



Âge scolaire



Contagiosité de 1 à 5 jours avant l'éruption

- Bon état général
- Pas de fièvre
- Parfois prurit cutané
- Arthralgies (adultes)



Conjonctives normales



Rash réticulé  
(érythème ajouré  
comme une broderie)



## ÉRUPTION RÉTICULÉE

- D'abord joues rouges comme gifiées par un vent froid puis éruption réticulée symétrique au niveau des avant-bras et des cuisses
- Parfois présence de quelques macules rosées sur le thorax
- Évolution à éclipses pendant quelques jours ou quelques semaines
- Éruption avivée par la pression, la chaleur, le soleil et l'exercice physique
- Pas de lésions muqueuses



Prévention

Contacts normaux :

informer, rassurer

Contacts à risque: surveillance

Femmes enceintes réceptives:  
surveillance obstétricale plus  
étroite, retrait préventif (?)



Traitement  
symptomatique

Risque embryo- foetal

Faible risque d'anasarque  
fœto-placentaire

Complications

Crise aplasique chez  
sujets à risque

Facteurs  de risque

Anémie chronique (anémie  
falciforme, sphérocytose,  
etc.), déficits immunitaires



Maladie bénigne  
pour l'enfant normal;  
guérison spontanée  
en 2 à 5 semaines



Test diagnostique:  
dépistage sérique des  
anticorps spécifiques



Examens complémentaires  
habituellement inutiles

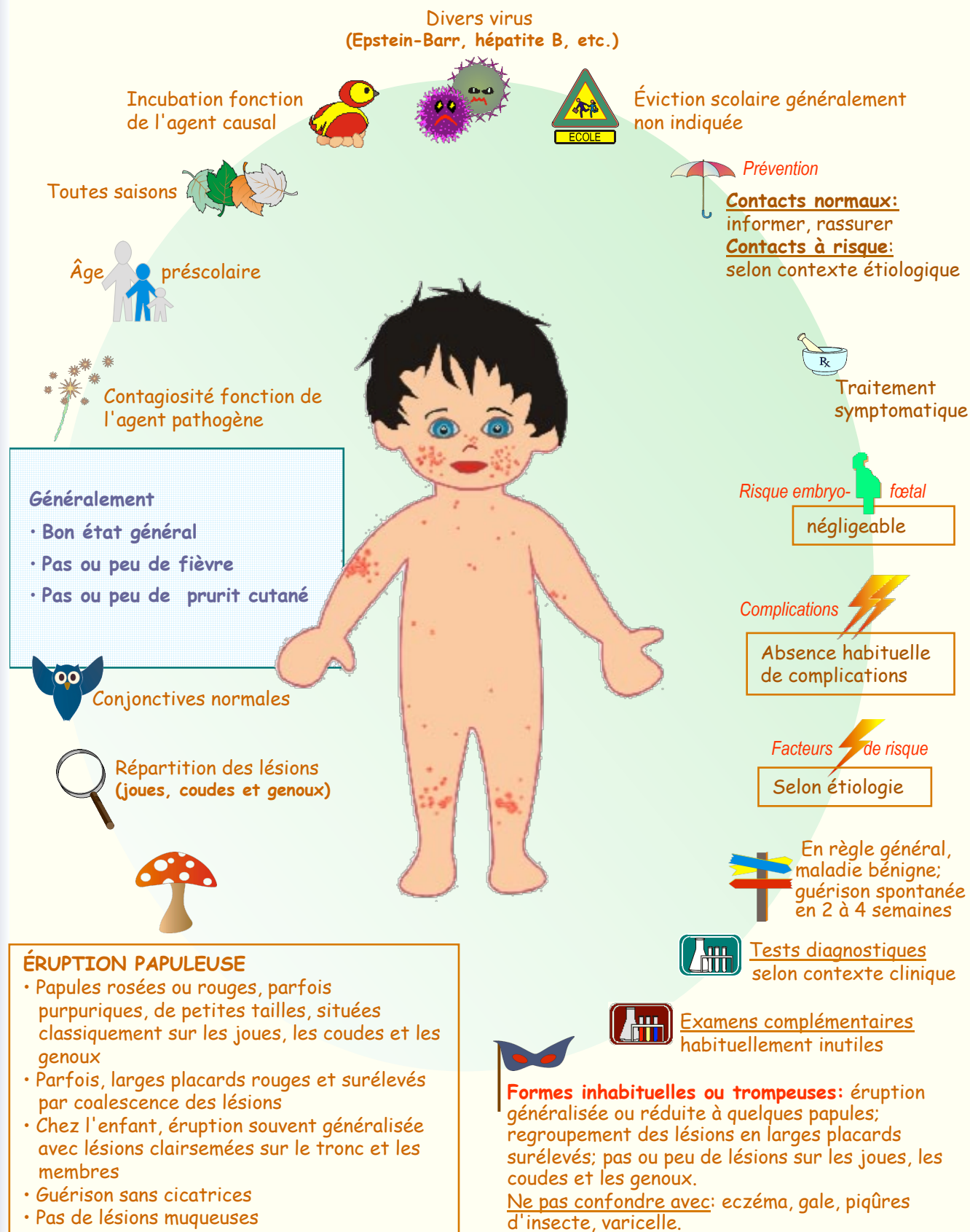


**Formes inhabituelles ou trompeuses**: forme  
inapparente, rash maculaire non réticulé, éruption  
généralisée, éruptions purpuriques (purpuras  
pétéchiaux, purpura d'Henoch)

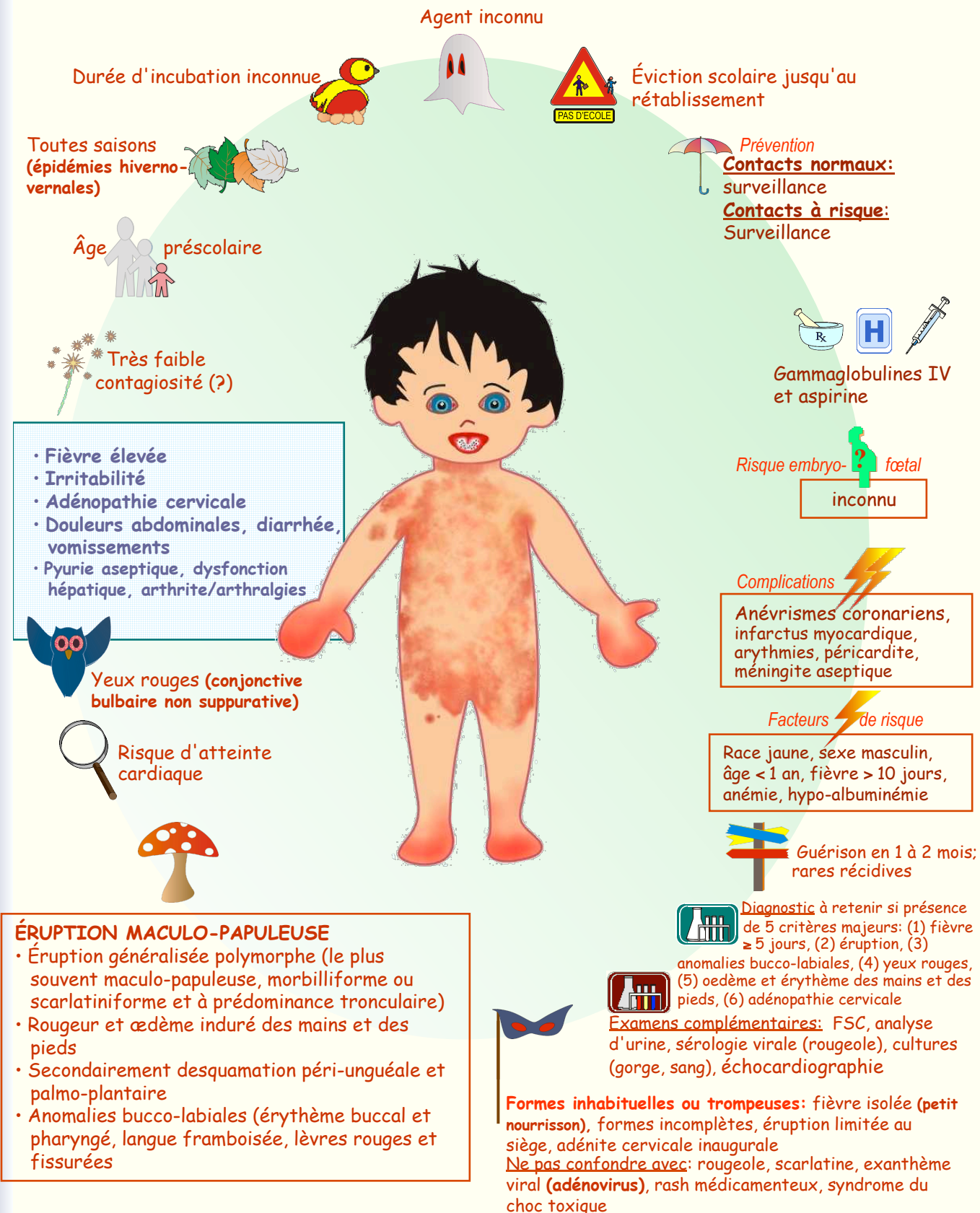
Ne pas confondre avec: rash allergique, purpura  
thrombopénique, rubéole et autres éruptions virales



# MALADIE DE GIANOTTI-CROSTI



# MALADIE DE KAWASAKI



# MALADIE "MAINS-PIEDS-BOUCHE"

Entérovirus non poliomyélitiques  
(Coxsackie A16, entérovirus 71, etc.)

Incubation de 3 à 6 jours



Éviction scolaire selon condition générale et symptomatologie

Saison estivale



Âge  préscolaire

Faible contagiosité  
(pendant une dizaine de jours)



- Bon état général
- Fièvre modérée
- Dysphagie, anorexie



Conjonctives normales



Distribution des lésions  
(mains, pieds, bouche et fesses)



## ÉRUPTION VÉSICULEUSE

- Vésicules à contenu clair ou citrin cernées d'un liseré rouge ou maculo-papules rouges situées au niveau des mains et des pieds
- Lésions maculo-papuleuses et vésiculeuses sur les fesses et sur le haut des cuisses
- Éléments papulo-vésiculeux au niveau du tronc et des membres peu nombreux et clairsemés
- Chez la fille, présence possible de lésions vésiculeuses inguinales et vulvo-périnéales
- Vésicules et lésions érosives douloureuses de la bouche et des lèvres



Prévention

Mesures d'hygiène habituelles



Traitement symptomatique

Risque embryo- foetal

négligeable

Complications

Rarement: myocardite, méningo-encéphalite, méningite aseptique

Facteurs  de risque

Déficits immunitaires



Maladie bénigne; guérison spontanée en une dizaine de jours



Au besoin, cultures virales (bouche, lésion cutanée)



Examens complémentaires habituellement inutiles



**Formes inhabituelles ou trompeuses:** lésions buccales isolées, lésions vulvaires vésiculeuses herpétiformes

Ne pas confondre avec: varicelle, infection herpétique, stomatite aphteuse

# PURPURA MÉNINGOCOCCÉMIQUE

*Neisseria meningitidis*  
(diplocoque Gram négatif)

Incubation de 1 à 10 jours



Éviction scolaire jusqu'au rétablissement

Toutes saisons



Tous âges



Contagiosité jusqu'à la fin du 1<sup>er</sup> jour d'antibiothérapie

**Tableau septicémique:** fièvre élevée, céphalée, douleurs abdominales, vomissements, toxicité, adynamie, prostration, irritabilité, frissons, arthralgies, myalgies.

**Purpura fulminans:** purpura extensif, pâleur, cyanose, extrémités froides, collapsus, choc, coma, décès



Conjonctives normales



**Purpura fébrile (TOUT PURPURA FÉBRILE EST A PRIORI MÉNINGOCOCCÉMIQUE)**



## ÉRUPTION PURPURIQUE

- Éruption purpurique généralisée
- Après apparition des premiers éléments purpuriques, pétéchie ou ecchymoses, généralisation très rapide du purpura: élargissement et multiplication des taches purpuriques puis apparition de lésions bulleuses et de placards nécrotiques
- Hémorragies muqueuses

Prévention

Chimioprophylaxie

pour l'entourage familial immédiat et les contacts étroits des 10 derniers jours.

Vaccination de l'entourage et des sujets à risque en cas d'épidémie

(Mesures préventives à prendre, si possible, dans les 24 heures qui suivent le diagnostic)



Antibiotique iv "stat" et hospitalisation dans une unité hospitalière de réanimation pédiatrique intensive

Risque embryo-foetal

Négligeable

Complications

Méningite, coagulation intra-vasculaire disséminée, nécroses cutanées, gangrène des extrémités, arthrite, pneumonie, péricardite

Facteurs de risque

Promiscuité (famille, garderie, école, pensionnat, caserne); déficits immunitaires



Bon pronostic si traitement rapide et absence de purpura fulminans



Tests diagnostiques:

frottis et cultures (LCR, sang, urine, liquide synovial, pleural ou péricardique, lésions cutanées)



Examens complémentaires: formule

sanguine, plaquettes, azotémie, créatininémie, glycémie, électrolytes sanguins, gaz artériels, bilan de coagulation; analyse des urines



**Formes inhabituelles ou trompeuses:** rash d'abord maculo-papuleux ou urticarien; stade précoce avec altération peu marquée de l'état général ou présence de rares pétéchie.

Ne pas confondre avec: purpura thrombopénique idiopathique, purpura d'Henoch, maltraitance, syndrome hémolytique urémique, purpura en cocarde



# ROSÉOLE (érythème subit, 6<sup>e</sup> maladie)

Herpesvirus humain type 6B

Incubation de 5 à 15 jours



Repos à domicile souhaitable pendant la phase fébrile

Toutes saisons



Âge  
préscolaire  
(6 à 24 mois)



Prévention

Mesures d'hygiène habituelles



Faible contagiosité pendant la phase fébrile

- Bon état général
- Fièvre élevée pendant 3 à 5 jours
- Irritabilité
- Tympanaux congestifs
- Anorexie, diarrhée
- Ganglions cervicaux postérieurs
- Parfois bombement de la fontanelle antérieure



Conjonctives normales



"Fièvre de 3 jours"  
puis éruption



## ÉRUPTION MACULO-PAPULEUSE.

- Taches rosées se localisant préférentiellement au niveau du tronc (surtout abdomen et région lombaire) et du visage (front)
- Éruption apparaissant dans les 24 à 48 heures suivant le retour de la température à la normale et disparaissant en moins de 3 jours, sans desquamation, ni pigmentation
- Parfois présence de petites lésions maculo-papuleuses au niveau du palais mou (**taches de Nagayama**)



Traitement  
symptomatique

Risque embryo-  
fœtal  
négligeable

Complications

Convulsions fébriles.  
**Rarement:** hypertension intracrânienne bénigne, méningo-encéphalite, hépatite, myocardite

Facteurs de risque

Transplantation, déficit immunitaire (risque de réactivation virale)



Maladie bénigne;  
guérison en près  
d'une semaine



Tests diagnostiques :  
culture et sérologie virales



Examens complémentaires  
inutiles si bon état général ou,  
au besoin, bilan d'une fièvre inexpliquée  
(leucopénie fréquente au stade fébrile)

**Formes inhabituelles ou trompeuses:** fièvre sans éruption ou éruption sans fièvre, forme précoce (avant 3 mois) ou tardive (grand enfant, adulte)

**Ne pas confondre avec:** infection à herpesvirus type 7 (**même tableau clinique**), autre rash viral, éruption médicamenteuse, bactériémie occulte

# ROUGEOLE (measles, rubeola)

Virus rougeoleux  
(paramyxovirus)

Incubation de 8 à 12 jours

Hiver  
et printemps

Nourrissons et  
adolescents

Forte contagiosité durant  
les 5 jours précédant et  
suivant le début du rash

- Malaise général, abattement, irritabilité
- Fièvre élevée
- Rhinorrhée, toux

Yeux rouges et larmoyants,  
photophobie

Taches de Koplik

## ÉRUPTION MACULO-PAPULEUSE

- Rash généralisé débutant au niveau du front et des régions rétro-auriculaires puis envahissant le visage, le tronc et les membres; disparition en 5 à 6 jours avec brunissement et desquamation furfuracée de la peau
- Éléments maculo-papuleux rouges espacés de peau saine sur le tronc et les membres, plus nombreux et coalescents sur le visage, le cou et les épaules
- Érythème des muqueuses bucco-pharyngées; dépôts blanchâtres à la face interne des joues (taches de Koplik)
- Parfois vésicules au niveau du palais mou



Éviction scolaire d'au moins 4 jours  
après le début de l'éruption

Prévention

**Contacts réceptifs:**

Gammaglobulines par voie  
intramusculaire (dans les 6  
jours qui suivent le  
diagnostic) **Entourage:**  
vaccination des sujets  
réceptifs

Traitement symptomatique;  
vitamine A si facteur de  
risque

Risque embryo-foetal

Faible risque de  
maladie congénitale

Complications

Otite, convulsion, diarrhée,  
pneumonie, laryngo-trachéo-  
bronchite, encéphalite,  
panencéphalite sclérosante  
subaiguë (incubation  $\pm$  10 ans)

Facteurs de risque

Premiers 12 mois de vie,  
déficits immunitaires,  
malnutrition, grossesse

Guérison en une  
dizaine de jours



**Examens diagnostiques :**

culture virale  
secrétions naso-pharyngées) et  
titrage sérique des anticorps  
spécifiques



**Examens complémentaires**

habituellement inutiles (en règle général,  
leucopénie au stade fébrile)



Formes inhabituelles ou trompeuses: éruption maculo-  
papuleuse purpurique, forme atténuée ou incomplète  
(chez enfants vaccinés ou après injection de  
gammaglobulines)

Ne pas confondre avec: maladie de Kawasaki, scarlatine,  
autre rash viral, toxidermie, allergie

# RUBÉOLE (rubella)

Virus rubéoleux  
(togavirus)

Incubation de 14 à 21 jours  
(moyenne de 17 jours)



Éviction scolaire pendant  
1 semaine (période contagieuse)

Hiver et printemps



Prévention

**Femmes enceintes réceptives:** surveillance sérologique, retrait préventif



Surtout nourrissons  
adolescents

Contagiosité de 7 jours  
avant à 7 jours après le  
début du rash (pendant  
plusieurs mois pour rubéole  
congénitale)

- Bon état général
- Pas ou peu de fièvre
- Adénopathies sous-occipitales et rétro-auriculaires
- Arthralgies distales (adolescents et adultes)



Conjonctives normales



Risque tératogène



Traitement  
symptomatique

Risque embryo- foetal

Risque d'embryopathie-  
fœtopathie tératogène

Complications

Maladie bénigne pour l'enfant normal. **Rarement:** encéphalite, purpura, anémie hémolytique, myocardite, péricardite

Facteurs  de risque

Grossesse



Guérison rapide de  
la forme acquise



**Examens diagnostiques :**  
culture virale  
(secrétions naso-pharyngées), dépistage  
sérique des anticorps spécifiques



**Examens complémentaires**  
habituellement inutiles



**Formes inhabituelles ou trompeuses:** forme inapparente ou fruste, aspect scarlatiniforme  
**Rubéole congénitale :** infection inapparente, fruste ou grave (cataractes, glaucome, cardiopathie, surdité, rétinite pigmentaire, purpura, hépato-splénomégalie, ictère, microcéphalie, méningo-encéphalite, hypertransparence osseuse)

Ne pas confondre avec: autre exanthème viral, scarlatine, rash médicamenteux

## ÉRUPTION MACULO-PAPULEUSE

- Éruption du visage puis du tronc et des membres
- Macules rouges ou rosées, espacées de peau saine, plus vives et plus denses sur les joues, plus clairsemées sur le tronc et les membres
- Éruption non prurigineuse s'effaçant en 3 à 4 jours
- Conjonctives normales ou un peu congestives
- Pas d'atteinte des muqueuses buccales ou, parfois, petites taches rouges sur le voile du palais (taches de Forcheimer)

# SCARLATINE

Streptocoque  $\beta$ -hémolytique  
du groupe A

Incubation de 2 à 5 jours

Toutes saisons

Âge scolaire

Contagiosité maximale  
au stade aigu de la maladie

- État général  $\pm$  bon
- Fièvre élevée
- Mal de gorge, dysphagie
- Adénopathies cervicales
- Douleurs abdominales
- Nausées, vomissements



Conjonctives normales

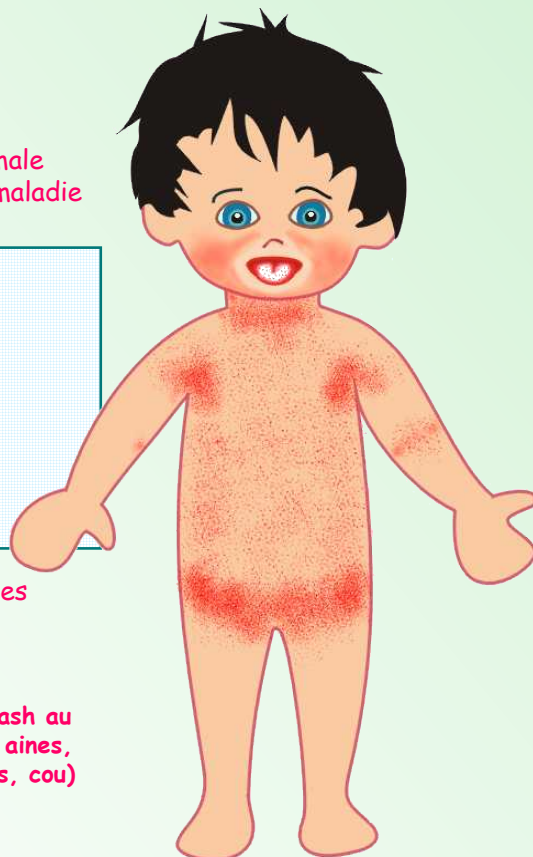


Signe de Pastia  
(accentuation du rash au  
niveau des plis - aines,  
coudes, aisselles, cou)



## ÉRUPTION ÉRYTHÉMATEUSE

- Peau rouge (comme un érythème solaire) et rêche (comme du papier sablé)
- Érythème généralisé prédominant au niveau de la face antérieure du tronc
- Pâleur du pourtour de la bouche et du nez si érythème du visage
- Éruption plus foncée au niveau des plis de flexion (signe de Pastia)
- Amygdales rouges et exsudatives, érythème et pétéchiies au niveau du palais, langue saburrale puis rouge framboise



Éviction scolaire jusqu'au  
rétablissement (plus de risque  
contagieux après 24 heures  
d'antibiothérapie)



Prévention

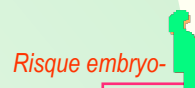
Contacts normaux :  
surveillance

Contacts à risque :  
culture de gorge



Antibiothérapie  
orale (pénicilline V)

Risque embryo-  
fœtal  
négligeable



Complications

Abcès périamygdalien,  
rhumatisme articulaire aigu,  
glomérulonéphrite aiguë

Facteurs de risque

Antécédents de rhumatisme  
articulaire aigu, de glomérulo-  
néphrite post-streptococcique



Guérison rapide  
sous antibiotique



Tests diagnostiques :  
culture de gorge



Examens complémentaires  
habituellement inutiles



**Formes inhabituelles ou trompeuses** : absence de fièvre,  
éruption peu visible ou limitée aux plis, purpura pétéchiial  
surajouté

Ne pas confondre avec : scarlatine staphylococcique  
(gorge normale mais présence d'un foyer septique :  
plaie, abcès, lésion varicelleuse), maladie de Kawasaki,  
toxidermie médicamenteuse, rougeole, infection à  
Arcanobacterium hæmolyticum (amygdalite exsudative,  
prurit cutané, adolescence)



# VARICELLE

Virus varicelle-zona

Incubation de  $\pm$  15 jours

Toutes saisons

Âge scolaire

Forte contagiosité durant les 5 jours qui précèdent le rash puis jusqu'à l'assèchement des lésions

- État général plutôt bon
- Fièvre modérée
- Prurit



Conjonctives normales



Vésicules et prurit



## ÉRUPTION VÉSICULEUSE

- Éruption à prédominance tronculaire
- Lésions maculo-papuleuses puis vésiculeuses et croûteuses
- Vésicules à liquide clair, citrin ou trouble, sur peau saine ou sur plaque érythémateuse
- Lésions croûteuses après affaissement et assèchement des vésicules
- Éruption débutant au niveau de la tête et du tronc puis s'étendant aux membres
- Dans un même territoire, présence d'éléments d'âge et d'aspect différents
- Éruption photosensible

Pendant le stade vésiculeux ou, si forme bénigne, selon les règlements sanitaires



## Prévention

**Contacts normaux :** surveillance

**Contacts à risque :** immunoglobulines de varicelle-zona (VariZIG)



Traitement symptomatique; acyclovir si facteur de risque

Risque embryo-foetal

Faible risque tératogène

## Complications

Impétigo, cellulite, scarlatine, pneumonies, hépatite, ataxie, encéphalite, glomérulo-néphrite, syndrome de Reye

## Facteurs de risque

Période néonatale, prématurité, âge adulte, déficits immunitaires, aspirine



Guérison en près d'une semaine



## Tests diagnostiques :

immunofluorescence, culture virale (vésicule) et titrage des IgM spécifiques



**Examens complémentaires** habituellement inutiles



**Formes inhabituelles ou trompeuses :** rash pauci-vésiculeux, distribution inhabituelle des lésions, réaction de photosensibilité, forme hémorragique, dermite/éruption surajoutée. **Varicelle congénitale :** hypoplasie d'un membre, microcéphalie, cataracte, chorio-rétinite, lésions cutanées

**Ne pas confondre avec :** piqûres d'insecte, maladie de Gianotti-Crosti, molluscum contagiosum, herpès cutané, folliculite, maladie mains-pieds-bouche

Teignes (Dermatophytoses)

1. Définition : Les dermatophytoses, communément appelées teignes, sont des infections fongiques superficielles de la peau, des cheveux et des ongles causées par des champignons appelés dermatophytes. Les principaux genres responsables sont Trichophyton, Microsporum, et Epidermophyton.



2. Modes de Transmission : Contact direct : Transmission par contact direct avec une personne infectée, un animal (zoonose), ou des surfaces contaminées (comme les sols ou les vêtements). Environnement : Les spores des dermatophytes peuvent survivre longtemps dans l'environnement, facilitant la propagation.

3. Présentations Cliniques : Teigne du cuir chevelu (Tinea capitis) : Perte de cheveux, plaques squameuses, souvent chez les enfants. Teigne du corps (Tinea corporis) : Plaques érythémateuses annulaire avec bordure surélevée et centre clair. Teigne des pieds (Tinea pedis) : Aussi appelée pied d'athlète, se manifeste par des fissures, des desquamations et des macérations interdigitaux. Teigne des ongles (Tinea unguium ou onychomycose) : Épaississement, décoloration et fragilité des ongles.

4. Diagnostic : Examen clinique : Observation des lésions typiques. Examens complémentaires : Examen direct des écailles cutanées sous microscope après préparation au KOH, culture fongique ou parfois biopsie cutanée.

5. Traitement : Antifongiques topiques : Utilisés pour les formes localisées, comme la teigne du corps (ex : clotrimazole, terbinafine). Antifongiques oraux : Nécessaires pour les formes étendues ou les atteintes du cuir chevelu et des ongles (ex : griséofulvine, terbinafine, itraconazole). Hygiène et prévention : Nettoyage des objets contaminés, éviter le partage d'objets personnels, traitement des animaux domestiques si nécessaire.

6. Complications : Surinfection bactérienne : Surtout en cas de grattage. Chronicité : Certaines formes, notamment l'onychomycose, peuvent devenir chroniques sans traitement approprié.

7. Prévention : Éducation : Importance de l'hygiène personnelle et de la gestion des animaux domestiques. Isolement : Isoler les cas confirmés jusqu'au début du traitement pour réduire la propagation.



Teignes vs Poux

Teigne (Tinea capitis) Pathogène : Infections fongiques, principalement causées par Trichophyton tonsurans ou Microsporum canis. Présentation clinique : Plaques squameuses prurigineuses rondes avec des cheveux cassés ou une alopecie dans les zones touchées. Peut être confondue avec une dermatite séborrhéique. Forme sévère : kérion (plaque profonde et molle avec formation de pustules). Adénopathie postauriculaire possible. Diagnostic : Examen des cheveux pour identifier les spores fongiques. Culture fongique pour confirmation. Traitement : Antifongiques oraux, comme la griséofulvine ou la terbinafine. Complications : Kérion peut entraîner une alopecie permanente si non traité.

| Caractéristique       | Teigne (Tinea capitis)                                           | Pédiculose (Poux de tête)                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Pathogène             | Trichophyton tonsurans, Microsporum canis                        | Pediculus humanus capitis                                             |
| Présentation clinique | Plaques squameuses prurigineuses avec alopecie                   | Prurit intense du cuir chevelu, excoriations, présence de lentes/poux |
| Lymphadénopathie      | Possible (postauriculaire)                                       | Rare                                                                  |
| Diagnostic            | Examen des cheveux, culture fongique                             | Détection visuelle des poux et lentes, lampe de Wood                  |
| Traitement            | Antifongiques oraux (griséofulvine, terbinafine)                 | Péliculicides topiques (perméthrine, ivermectine), retrait mécanique  |
| Complications         | Kérion (peut causer alopecie permanente)                         | Surinfections cutanées dues aux grattages                             |
| Transmission          | Contact avec des surfaces ou objets contaminés, animaux infectés | Contact direct tête-à-tête ou partage d'articles personnels           |
| Zones affectées       | Cuir chevelu, parfois sourcils et cils                           | Cuir chevelu, principalement derrière les oreilles et la nuque        |
| Épidémiologie         | Enfants, plus fréquent dans les zones surpeuplées                | Enfants en âge scolaire, épidémies fréquentes dans les écoles         |

Pédiculose (Poux de tête) Pathogène : Pediculus humanus capitis, un ectoparasite qui se nourrit de sang humain. Présentation clinique : Prurit intense du cuir chevelu et de la nuque, souvent associé à des excoriations dues au grattage. Présence de lentes (œufs) et de poux visibles sur les cheveux. Les lentes se fixent aux cheveux près du cuir chevelu, particulièrement derrière les oreilles et à la base du cou. Diagnostic : Détection visuelle des poux ou des lentes, souvent visible à l'œil nu ou sous une lampe de Wood. Traitement : Application topique de péliculicides (shampooing à la perméthrine, malathion, ivermectine topique). Retrait mécanique des poux et lentes avec un peigne fin. Lavage et séchage à haute température des articles contaminés (linge, literie). Complications : Surinfections cutanées dues aux grattages. Différenciation clé

Nature de la lésion : La teigne se manifeste par des plaques squameuses avec perte de cheveux, tandis que la pédiculose se manifeste par un prurit intense sans alopecie associée, mais avec la présence de poux et de lentes. Lymphadénopathie : Peut être présente dans la teigne, surtout avec des infections sévères (kérion), mais est rare dans la pédiculose. Traitement : La teigne nécessite un traitement antifongique systémique, tandis que la pédiculose est traitée avec des péliculicides topiques.

## Morptions (Phtiriase Pubienne):

### Parasite

- Nom scientifique : *Pthirus pubis* (aussi appelé pou du pubis ou "crabe" en raison de son apparence).

### Transmission

- Principalement par **contact sexuel**.
- Peut également se transmettre par des objets contaminés, comme des serviettes ou de la literie.

### Épidémiologie

- Plus fréquent chez les adolescents et les jeunes adultes.

### Présentation Clinique

- **Prurit** et excoriations dans la région pubienne, pouvant s'étendre aux zones périnatales et axillaires.
- Apparition possible de **macules céruléennes** (taches bleuâtres) chez les patients atteints d'infections chroniques.

### Diagnostic

- Identification des poux ou des lentes dans les poils pubiens à l'œil nu, au microscope ou à la lampe de Wood.

### Prise en Charge

- Application topique de pédiculicides (ex. crème de perméthrine à 1%) pendant 10 minutes.
- Réévaluation après 9-10 jours et répétition du traitement si des poux sont encore présents.
- Lavage en machine et séchage à haute température ( $\geq 55^{\circ}\text{C}$ ) de la literie, des vêtements, etc., ou leur isolation dans un sac plastique scellé pendant 2 semaines.
- Dépistage des autres infections sexuellement transmissibles (IST) et traitement des partenaires sexuels pour prévenir la réinfection.



## Gale

### Mode de Transmission

- La gale se transmet principalement par **contact direct** entre humains, souvent prolongé et étroit. La transmission **indirecte** par des objets contaminés (comme des vêtements ou de la literie) est rare mais possible.

### Présentation Clinique

- **Prurit intense, surtout la nuit.**
- **Lésions cutanées** : papules érythémateuses allongées, sillons (2-10 mm de long), vésicules, excoriations, croûtes, et hyperpigmentation post-inflammatoire.
- Sites de prédilection : **poignets, doigts, espaces interdigitaux, organes génitaux masculins**, autres zones intertrigineuses (aisselles, fesses), régions périanale et péri-ombilicale.
- Les personnes immunodéprimées ou âgées peuvent présenter des formes plus graves, comme la gale croûteuse.

### Diagnostic

- Diagnostic principalement clinique, basé sur les symptômes et les lésions caractéristiques.
- Détection des acariens, larves, œufs ou matières fécales au dermatoscope ou par examen microscopique de raclures cutanées.

### Prise en Charge

- Traitement de première ligne : **crème de perméthrine** à 5 %, avec une application répétée une semaine plus tard si nécessaire.
- Alternatives pour les adultes : **ivermectine orale**, crotamiton, lotion de lindane (rarement utilisée en raison de sa toxicité).
- Traitement des symptômes : antihistaminiques oraux et/ou corticostéroïdes topiques pour le prurit, antibiotiques en cas d'infection bactérienne secondaire.

### Prévention

- Mesures pour prévenir la transmission et la réinfection : lavage de tous les vêtements et literie à  $\geq 50^{\circ}\text{C}$ , traitement des contacts proches (membres de la famille, partenaires sexuels).
- Éviter le contact direct avec les patients jusqu'à la fin du traitement.
- Pour les objets non lavables, les isoler dans un sac en plastique scellé pendant 3 à 7 jours.



## Punaises de Lit

Les punaises de lit sont des arthropodes ectoparasites de la famille des Cimicidae qui se nourrissent de sang. Elles se cachent généralement pendant la journée et sortent la nuit pour se nourrir. Elles sont principalement transmises par contact direct avec des lits ou des meubles infestés.

### Présentation Clinique

- Les piqûres de punaises de lit se manifestent par des lésions maculopapuleuses érythémateuses prurigineuses de 2 à 5 mm, apparaissant en quelques heures ou en plusieurs jours.
- Les piqûres sont souvent indolores au début, mais un prurit intense se développe par la suite.
- Elles se localisent principalement sur les zones de peau non couvertes pendant le sommeil, comme le cou, le visage, les bras et les mains.
- Les piqûres sont souvent regroupées ou forment un motif linéaire ("petit déjeuner, déjeuner, dîner").

### Diagnostic

- Le diagnostic est basé sur l'apparence des lésions cutanées ainsi que la présence de signes d'infestation par les punaises de lit dans l'environnement du patient (par exemple, exosquelettes, taches noires sur les draps).

### Prise en Charge

- Traitement symptomatique du prurit.
- Décontamination de tous les meubles et textiles.
- Les complications peuvent inclure des infections secondaires (e.g., folliculite) et des effets psychologiques (e.g., anxiété, hypervigilance).